



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ورده سيد على سيد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : المقطم
العنوان : ممممممممممم
رقم البطاقة : 27411262201025 رقم التليفون : 01155037643
العمر (تاريخ الميلاد) : 26-11-1974 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الأورام

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض
بالصبغة [11127]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: وردة سيد علي سيد National ID: 27411262201025	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية
مركز إدارة الهوية والجنسية

ورده
سيد علي سيد
٥٦ هي الاسمرات عمارة الجوهرة
المقطم - القاهرة

١٩٧٤/١/٢٧
٢٧٤١١ ٣٦٧٧ ٠١٠ ٢٥

KN7303298





Name: ورده سيد علي سيد		
MR. : 6627		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient's tumor is characterized as invasive ductal carcinoma (IDC) with estrogen receptor (ER) positivity of 5/8, progesterone receptor (PR) positivity of 2/8, HER2 score of +3, and a Ki-67 proliferation index indicating high proliferative activity. The disease is located in the left breast (LUMBECTOY). The treatment plan includes chemotherapy with an unspecified regimen, HERCEPTIN (trastuzumab), and radiotherapy targeting the femur. The current management strategy is to proceed with these systemic and local therapies.		
تحريرا في ,		
	التاريخ : 19-09-2026	الوقت :
	Emad Hassan Ibrahim	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



ImmunohistoChemistry report

Report Number: m973

Female : النوع
القاهرة : العنوان
17/02/2021 09:59 : تاريخ استلام العينة
24/02/2021 09:59 : تاريخ التقرير

وردة سيد على
46 Y

مركز اورام دار السلام
مركز أورام دار السلام

Primary Sample :

Affin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER & PR: Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

Sample received was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody. - CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.

Sample received was treated by: - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB DAB-Plus in Ventana Benchmark GX.

Sample received was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

R: strong nuclear staining of 80 % of tumour cells

R: moderate nuclear staining of 70 % of tumour cells

ER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.

Ki67 : positive nuclear staining of about 50 % of tumour cells

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8/8)

PR: POSITIVE (SCORE 7/8)

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3 +)

Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 50 %

Pathologist:

د/أيناس رمزي

Lab Director: د/ نورا ماهر

Pathology Report

Name: وردة سيد على

Age: 46 years.

Clinical data :Right breast mass, post chemotherapy.

Specimen type: Wide local excision and sentinel lymph node(SLN).

Date (Received):18/3/2021

Date(reported): 30/3/2021

Lab. Number: 508/21

Hospital Number:

Gross Description: Two containers received submitted as:-

- 1- Wide local excision (WLE)measured 8x5x2cm, partially covered by skin ellip 7x3cm. Serial sections revealed ill-defined subcutaneous mass 1.5x1x1 cm.
- 2- SLN 4 nodules , the largest measure 1.5x1cm.

Microscopic examination:

histopathological examination of sections prepared from the lumpectomy specimen received reveals an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate [grade II]. Minimal insitu component is detected. There is no perineural infiltration, no vascular tumor emboli. Surgical margins and skin are free.

Diagnosis:

Right breast mass, WLE and SLNs, post chemotherapy:

- Invasive duct carcinoma grade II.
- Minimal insitu component.
- Incomplete response to therapy
- No perineural invasive.
- No Vascular tumor emboli.
- Free margins and covering skin
- Free SLN (0/4).
- Stage ypT1 ypN0.

Prof. Dr. Amal Hareedy.

Dr. Marwa Mahmoud.

Dr. Mona Mohamed.

Pathology Report

[[{"TYPE": "PATHOLOGY_REPORT"}]]



POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST & ABDOMEN & PELVIS: -

Chest:

- Known case of right breast cancer
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes, yet few prominent axillary LNs.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

Abdomen & Pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesion or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stone or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticula outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Reviewing skeletal parts revealed no lytic or sclerotic osseous lesions.

OPINION:

- Known case of right breast cancer
- ***No ct evidence of pulmonary or hepatic metastatic disease.***

Much Obligated,
Dr. Sherif Sameh, M.D.
Dr. M. Gomaa, M.D.



Patient Name: Warda Sayed Ali Date: 12/6/2021

Tc-99m MDP bone scan.

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique:

Delayed Anterior and posterior whole body scan 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP.

Report:

Delayed Static Phase:-

- Degenerative changes are noticed over dorso-lumbar vertebrae
- No definite evidence of malignant osseous deposits are seen at the rest of the surveyed skeleton .
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

- No definite evidence of osseous neoplastic lesion.

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Sherien Mahdy, M.D.